

西药药剂头孢米诺的药理作用、药物相互作用分析

林 玉,陈 燊 (福建省立医院药学部,福建 福州 350001)

摘 要 目的:探究西药药剂头孢米诺的药理作用、药物相互作用。方法:选取 68 例使用头孢米诺药物的患者,对药理作用以药物相互作用进行分析。结果:头孢米诺在临床治疗中不会产生抗菌活性代谢物,通过肾脏实现排泄,该药物和其他药物之间可能出现相互反应。结论:对患者使用头孢米诺之前需要展开皮试,防止患者用药之后不会出现过敏情况,并在治疗后对患者临床症状进行分析与观察。

关键词 西药药剂;头孢米诺;药理作用;药物相互作用

头孢米诺是一种头霉素类药物,具有抗菌谱广、杀菌力强以及适应证多等特点,在治疗敏感菌引起的呼吸道感染、胆道感染以及泌尿系统感染、扁桃体炎和败血症等临床治疗中应用广泛^[1]。在对该疾病患者治疗中,不仅要提高对患者的治疗效果,还需要兼顾患者治疗中可能出现的不良反应。因而为了进一步探究头孢米诺的临床应用方法、药理作用以及药物相互作用,现选取 68 例使用头孢米诺药物的患者进行探究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:研究中共选取 68 例使用头孢米诺药物的患者,2018 年 7 月是研究开始时间,2019 年 7 月是研究截止时间。患者包括呼吸道感染和泌尿系统感染。男 35 例,女 33 例;年龄 18~59 岁,平均(38.50±10.25)岁。纳入标准:了解研究内容,并自愿参与。排除标准:曾有或现有精神疾病患者;中途退出患者。

1.2 方法:对下呼吸道感染患者治疗过程中使用 2 g 头孢米诺药物配合浓度 5% 的葡萄糖液 100 ml,选择静脉滴注的方式,2 次/d,在对患者使用头孢米诺药物的同时不给予其他抗菌药物;对泌尿感染患者治疗中使用 2 g 的头孢米诺配合 400 ml 0.9%NaCl 注射液,静脉注射,2 次/d。

1.3 观察指标:①观察患者治疗效果:痊愈:临床症状全部消失;显效:临床症状得到明显改善;无效:临床症状未改善甚至加重。总有效率=(痊愈例数+显效例数)/总例数×100%。②观察患者不良反应发生率,包括过敏、蛋白尿以及恶心。

1.4 统计学方法:将患者信息输入 Excel 表格后进行分组。分组数据输入 SPSS22.0 统计学软件,治疗效果、不良反应发生率以 χ^2 分析,以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗效果比较:治疗后,痊愈 43 例(62.23%),显效 20 例(29.41%),无效 5 例(7.35%),总有效率 63 例(92.64%)。

2.2 不良反应发生率比较:治疗后,过敏不良反应发生率为 1 例(1.47%);蛋白尿不良反应发生率为 1 例(1.47%);恶心不良反应发生率为 2 例(2.94%),总不良反应发生率为 3 例(4.41%)。

3 讨论

头孢米诺是一种抗生素,其性质类似于第三代头孢菌素,主要的色泽与状态表现为白色或者白色结晶性粉末状,能够与谁进行有效相容^[2]。在研究中显示,使用头孢米诺后主要通过肾脏进行排泄,其半衰期时间为 2.5 h,能够发挥比较长时间的药效,碎石存在中度肾功能障碍的患者,在服用药物 12 h 后大概有 60% 药物可以随着尿液排出,而对于存在重度肾功能障碍的患者,在服用药物后 24 h 可能只有 10% 左右的药物随着尿液排出^[3]。对于 0.5 g 剂量的头孢米诺而言,使用静脉滴注的方式为患者注射后,血药浓度可以达到 100 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 左右,此时即为浓度的最高峰值^[4]。并且在治疗过程中,该药物进入人体后可以分布于卵巢、输卵管以及子宫内膜等部位,在痰液、胸腔积液以及胆汁中都可以表现出比较高的浓度,但在治疗中不论是静脉注射还是肌肉注射,都能够达到良好的浓度,从而提高治疗效果,并且在体内几乎不会发生代谢的情况^[5]。在治疗过程中,头孢米诺对因腹膜炎、胆囊炎导致的腹腔感染的患者、因肺炎、支气管炎、扁桃体周围脓肿导致的呼吸系统感染与肺部感染的患者、因子宫附件炎、子宫内感染导致的盆腔感染的患者有比较良好的效果^[6]。但是在相关研究中显示,与孢西丁等药物相比较,头孢米诺对于厌氧球菌的活性比较差,所以在治疗之前需要对患者进行仔细检查,保证在明确病菌感染症状之后进行针对性治疗^[7]。由于头孢米诺属于西药药剂,治疗过程中不有效控制剂量的情况下很容易出现各种不良反应,影响治疗效果。所以在对患者展开治疗的过程中需要加强对药物使用方式的注意,通常情况下,头孢米诺使用方式主要包括静脉滴注和静脉注射等方式,所以在治疗中儿童使用的次数为 3~4 次,每次使用的计量为 20 mg/kg,在对成年患者进行治疗的过程中,每天使

通讯作者:陈 燊

用的次数为 2 次,每次使用的计量为 1 g^[9]。不过在治疗过程中,对于患有败血症的患儿治疗中需要采用口服的方式进行治疗,2~4 次/d,每次 40~60 mg/kg,而对于患有败血症的成年患者治疗中则需要 3~4 次/d,6 g/d^[9]。而且在治疗过程中相关护理人员需要保证每 100~200 ml 的注射液中含有 1 g 的头孢米诺,并且滴注的时间需要根据患者的具体情况进行调整与控制。

头孢米诺在药理作用中具有抗菌谱广、杀菌能力强以及适应证多等特点,而且在治疗过程中发挥药理作用的原因主要是头孢米诺与青霉素结合蛋白具有比较强的亲和性,使头孢米诺能够更好地与青霉素结合蛋白进行有效结合,从而起到抑制细菌细胞壁合成的作用^[10]。其次,在治疗过程中,头孢米诺能够与细菌细胞壁上的肽多糖进行结合,进一步抑制肽多糖和脂蛋白的结合,有效促进细菌溶解,进一步起到强力杀菌的作用^[11]。而且在治疗过程中,头孢米诺与其他同类型的药物比较药理作用更加明显,但是也存在一定局限性,所以在治疗过程中需要根据患者具体情况选择针对性药物,更好地提高治疗效果。

对患者展开治疗中,头孢米诺在一定的时间、环境以及温度下具有比较稳定的药效,而且在相关研究中显示,头孢米诺能够与生理盐水、葡萄糖生理盐水、利巴韦林、甘油果糖、木糖醇、更昔洛韦、替硝唑、右旋糖酐、左氧氟沙星、加替沙星、碳酸氢钠、氨甲苯酸等药物进行联合使用,更好地提高治疗效果^[12]。在联合使用的过程中,需要注意如果与硫酸、呋喃硫胺、氯化可的松琥珀酸钠、腺苷钴胺、维生素 B₁ 进行配伍的情况下药物的颜色会发生变化,说明头孢米诺与相关药物并不适合配伍。且需要注意的是,头孢米诺并不能与呋塞米等药物联合使用,防止在治疗过程中对患者的肾脏功能造成损伤,从而进一步降低不良反应,提高治疗效果。而且在对患者展开头孢米诺药物治疗的过程中,需要告知患者禁止吸烟喝酒,因为头孢米诺一定程度上会影响患者体内乙醇的正常代谢,提高患者体内的乙醇浓度^[13]。除此之外,在对患者展开治疗的过程中,需要注意不能与氨茶碱、磷酸吡多醛等药物联合使用,防止治疗过程中对头孢米诺的正常使用产生不良影响,降低治疗效果。

对患者展开头孢米诺药物治疗的过程中,或多或少会出现不同程度的不良反应,包括过敏反应、消化道反应等。其中过敏反应主要表现为皮肤瘙痒、皮疹、荨麻疹以及药物热等^[14]。消化道反应主要表现为食欲减退、呕吐、恶心以及腹泻等。而在对患者采取口服治疗该药物的过程中可能会出现休克反应,并且伴有耳鸣,如果口腔中存在异物,患者的病情在比较严重的情况下可能出现盗汗或者便秘等不良反应。除此之外,在对该疾病患者展开治疗的过程中可能会导致体内血细胞减少、红细胞和粒细胞减少、血红蛋白减少、血小板减少或增多、嗜酸粒细胞增多、血细胞比容减低以及中性粒细胞减少等不良反应情况的发生。且对患者肾功能也可能造成一定影响。在对患者展开治疗中,头孢米诺的用药禁忌证主要有妊娠期、临床检验、青霉素过敏者等,主要因为头孢米诺可

由脑髓野向乳汁运行,再加上妊娠患者对头孢米诺的了解甚少,所以在妊娠时期需要禁止使用该药物。头孢米诺可对临床检验值产生影响,如尿糖试验可能会出现假阳性情况等,所以接受临床检验的患者需要禁止使用该药物。使用头孢米诺后可能会出现伪膜性大肠炎等症状,所以患者在用药期间若发生频繁腹泻不良情况的时候,则需要慎用该药物。除此之外,头孢米诺在治疗过程中能导致患者发生 PIE 综合征、中毒性表皮坏死症以及皮肤黏膜炎综合征等不良反应情况,所以在对患者进行头孢米诺药物治疗的过程中需要密切关注患者的病情变化,如果出现相关不良反应的情况需要及时停止用药,并进行针对性处理,最大程度上提高治疗的安全性。本次研究结果中显示,对患者实施头孢米诺药物治疗后,治疗效果痊愈 43 例(62.23%),显效 20 例(29.41%),总有效率为 92.64%。治疗过程中过敏不良反应发生率为 1 例(1.47%)、蛋白尿不良反应发生率为 1 例(1.47%)、恶心不良反应发生率为 2 例(2.94%),充分证实对患者展开治疗的过程中需要根据具体情况展开针对性治疗,最大程度上降低不良反应情况的发生,提高治疗效果。

4 参考文献

- [1] 张欣媛,熊鑫,陈旭,等. 西药药剂头孢米诺的临床应用研究[J]. 中国医药指南,2020,18(11):158-159.
- [2] 蒋萍萍. 西药药剂头孢米诺的药理作用、药物相互作用研究[J]. 家庭医药·就医选药,2020,(5):199-200.
- [3] 耿兴星. 头孢菌素类抗生素联合其他药物治疗致不良反应发生情况分析[J]. 临床合理用药杂志,2020,13(3):91-92.
- [4] 葛星峰,李思柔. 头孢米诺钠与左氧氟沙星对医院获得性肺部感染患者的疗效及其对炎症因子的影响[J]. 抗感染药学,2019,16(12):2176-2178.
- [5] 孙春莲. 临床西药药剂头孢米诺的应用效果观察[J]. 临床合理用药杂志,2020,13(13):84-85.
- [6] 张博. 我院注射用头孢米诺钠临床应用情况及合理性分析[J]. 药品评价,2019,16(8):36-37,40.
- [7] 赵芮,马静婷,魏丽娜,等. 头孢米诺钠致维生素 K 依赖性凝血因子缺乏症[J]. 药物不良反应杂志,2019,21(1):59-60.
- [8] 陈婧,史涛. 头孢米诺钠治疗医院获得性肺部感染临床研究[J]. 陕西医学杂志,2018,47(4):506-508.
- [9] 张锋,景元彬. 头孢米诺钠治疗糖尿病合并社区获得性下呼吸道感染的临床分析[J]. 糖尿病新世界,2018,21(9):72-73.
- [10] 叶常青,谢燕如,蔡丽红. 头孢米诺的临床应用效果及不良反应[J]. 糖尿病天地,2018,15(9):94.
- [11] 张旭,钱坤,李鸿录. 临床中西药药剂头孢米诺的应用效果评价[J]. 当代医学,2020,26(7):109-111.
- [12] 关爱萍. 我院呼吸内科住院部抗菌药物应用分析[J]. 北方药学,2020,17(4):195-196.

[3] 郝洲华,李 盛,郝 杰,等. 对引起泌尿生殖系统感染的大肠埃希菌耐药性的分析 [J]. 当代医药论丛, 2020, 18 (4): 64-65.

[4] 刘 洁,杨 晶,高立芳,等. 862 例医院感染患者病原菌菌种及其耐药性分析 [J]. 山东医药, 2019, 59(27): 33-37.

收稿日期: 2020-07-31 编校: 王丽娜

甲强龙辅助治疗 ICU 急性心力衰竭患者的有效性研究

林县杰 (广东省中山市东凤人民医院, 广东 中山 528425)

摘 要 目的: 探讨甲强龙辅助治疗 ICU 急性心力衰竭患者的有效性。方法: 选择 ICU 急性心力衰竭患者 78 例, 分为对照组以及研究组, 对照组接受常规治疗, 研究组则接受常规治疗+甲强龙辅助治疗, 对比两组患者的疗效差异。结果: 治疗前心功能与血钾浓度对比差异无统计学意义 ($P>0.05$); 治疗后研究组的 LVSD 低于对照组, LVEF、血钾浓度高于对照组, 差异有统计学意义 ($P<0.05$)。研究组的治疗有效率 94.87%, 高于对照组的 84.61%, 差异有统计学意义 ($P<0.05$)。结论: ICU 急性心力衰竭患者在接受常规治疗的同时, 给予患者甲强龙辅助治疗, 能有效改善患者的心功能, 促进疾病的好转, 该治疗方法值得推广。

关键词 甲强龙; 辅助治疗; ICU 急性心力衰竭患者; 有效性

慢性心力衰竭疾病的发生与患者自身存在心血管病变有关, 而重症心力衰竭是患者病情发展至中晚期, 心功能严重受损, 若不及时采取有效治疗的措施, 则会导致患者的生命健康受到威胁。我国心力衰竭疾病的发生率为 0.9%, 随着人口老龄化的提升, 该疾病的发生率不断上升。临床上对于心力衰竭主要是采用利尿剂、 β -受体阻滞剂、洋地黄类药物进行抗心力衰竭治疗, 同时给予患者补液、氧气吸入、纠正酸碱失衡等维持对症治疗, 但是患者的临床治疗效果欠佳^[1]。糖皮质激素类药物用于心力衰竭疾病的治疗中, 可以发挥辅助治疗作用, 通过静脉输注, 可以提升患者自身的免疫水平, 抑制炎症因子的释放, 增强心肌收缩力^[2]。本次研究中, 着重探讨 ICU 急性心力衰竭患者治疗中采用甲强龙辅助治疗的临床效果, 对照组接受常规治疗, 研究组则接受常规治疗+甲强龙辅助治疗, 现将研究结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料: 纳入我院 2018 年 7 月~2019 年 12 月收治的 ICU 急性心力衰竭患者共 78 例, 分为对照组及研究组。对照组中男 19 例, 女 20 例, 年龄 43~84 岁, 平均 (64.18 $\pm$ 3.94) 岁; 心功能分级: II 级 4 例, III 级 19 例, IV 级 16 例; 合并高血压 9 例, 合并冠心病 10 例, 合并糖尿病 7 例, 合并扩张型心肌病 13 例。研究组中男 18 例, 女 21 例, 年龄 44~85 岁, 平均 (64.57 $\pm$ 3.81) 岁; 心功能分级: II 级 5 例, III 级 20 例, IV 级 14 例; 合并高血压 8 例, 合并冠心病 9 例, 合并糖尿病 10 例, 合并扩张型心肌病 12 例; 统计学分析两组患者的一般资料比较, 差异均无统计学意义 ($P>0.05$), 具有可比性。本次研究经本院医学伦理委员会同意。纳入标准: ①均为重症急性心力衰竭患者; ②患者以及家属对本次研究知情, 自愿参与本次研究。排除标准: ①存在严重的肝、肾、肺等重大器官疾病; ②存在意识障碍、精神疾病; ③合并恶性肿瘤; ④已经使用过糖皮质激素辅助治疗者; ⑤对糖皮质激素类药物过敏者; ⑥拒绝参加本次

研究。

1.2 方法: 对照组接受常规治疗, 给予患者氧气吸入、补液、维持水电解质平衡、维持机体酸碱度等对症治疗措施, 同时给予患者 β 受体阻滞剂以及利尿剂治疗, 让患者口服美托洛尔 (批准文号: 国药准字 H32025390; 生产企业: 阿斯利康制药有限公司), 1 次/d, 100 mg/次; 口服螺内酯片 (批准文号: 国药准字 H32020077; 生产企业: 江苏正大丰海制药有限公司), 1 次/d, 60 mg/次。

研究组则接受常规治疗+甲强龙辅助治疗, 常规治疗同对照组, 静脉注射甲强龙 (批准文号: 进口药品注册证号 H20170197; 生产企业: Pfizer Manufacturing Belgium NV), 注射剂量为 30 mg/kg。两组患者均连续治疗 4 周。

1.3 观察指标: 在研究结束后, 将患者治疗前后的心功能 (LVSD、LVEF) 与血钾浓度统计记录。疗效评估^[3]: 显效: 患者的临床症状消失, 心功能在 1~2 级; 有效: 患者的临床症状显著改善, 心功能为 2 级; 无效: 患者的临床症状无好转, 心功能 3~4 级。治疗总有效率 = (有效例数 + 显效例数) $\div$ 总例数 $\times$ 100%。

1.4 统计学方法: 采用 SPSS25.0 软件中展开数据统计学计算, 计量资料以均数 $\pm$ 标准差 ($\bar{x}\pm s$) 表示, 采用 t 检验, 计数资料以率 (%) 表示, 采用 χ^2 检验, $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的治疗前后的心功能与血钾浓度对比: 治疗前, 心功能与血钾浓度对比差异无统计学意义 ($P>0.05$); 治疗后, 研究组的 LVSD 低于对照组, LVEF、血钾浓度高于对照组, 差异有统计学意义 ($P<0.05$)。见表 1。

2.2 两组患者疗效对比: 研究组治疗总有效率 94.87%, 高于对照组的 84.61%, 差异有统计学意义 ($P<0.05$)。见表 2。